EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 79734
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-02-28 12:46:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DOMINGO ANTONIO MORALES MORALES			**RUN**	: 7.825.053-4
F.Nac	: 21-02-2024	**Edad**	: 0 AÑO	**Género**	: Masculino
Dirección	:			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-02-22	**Fecha Egreso**	: 2024-02-28 12:46:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I48.1-FIBRILACION AURICULAR PERSISTENTE

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Neumonia basal izquierda en tratamiento
Obs sd. abstinencia OH en tratamiento
Temblor de reposo
FA Superada con cardioversión eléctrica
Cardiopatía Valvular con FEVI conservada: Estenosis valvular aortica severa +Insuficiencia moderada.
LRA KDIGO 2 superada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Pcte sin antecedentes mórbidos consulta en SU HSC por cuadro de disnea asociado a palpitaciones que se exacerban, habría tenido consulta previa hace 48 hrs aprox donde se diagnosticó neumonía basal y rechaza hospitalización, se indicó levofloxacino como tratamiento ambulatorio.Ingresa en malas condiciones generales, taquicárdico, desaturando, pálido y con compromiso hemodinámico; ECG ingreso FA c/RVR, se indicó lantócido C sin respuesta clínica Dentro de exámenes de laboratorio destaca crea 2.0, , MDRD 30, PCR 87, uremia 112, ELP 144/4.7/109, INR 1.99, TP 40%, GSA pH 7.32, pO2 148.5, pCO2 11.7, HCO3 6 Se evalúa a paciente en malas condiciones generales, persiste disneico, taquicárdico, con PAM límite, GCS 14, sat 99% con MV 35%; se decide ingreso rápido a unidad para manejo médico óptimo.
Ingresa a UTI con evolución favorable en tratamiento ATB primera linea bien tolerado, afebril con px inflamatorios bajos y mejoría clinica. Del punto de vista CV control de FA con amiodarona y tratamiento anticoagulante con clexane (Dra Gomes exceptua manejo GEs debido a condicion social / alcoholismo no candidato a cirugía valvular. FA con CHADSVASC 1 punto y HASBLEED 2 puntos. Probablemente no candidato por score médico + riesgo social a terapia anticoagulante. Al alta control Poli Cardiologia y definir conducta). En cuanto a su ambito social pendiente evaluación por servicio social y respuesta. Se logra solo contacto con sobrina quien acude a visita manifiesta escaso contacto con hijos del paciente.
Dado buena evolucion clínica se decide traslado a medicina para continuar ajuste de terapia crónica y ATB. cOMPLETA 7 DIAS DE CEFTRIAXONA.

ACTUALEMNTE EN BEG, SIN REQ DE OXIGENO ADICIONAL, HD ESTABLE, AFEBRIL, PARAMETROS INFLAMATORIOS FRANCAMENTE A LA BAJA

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR SEGUIMIENTO HODOM
CONTROL POLI CARDIO

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO SEMISENTADO, CONTENCION SOS
2. REGIMEN LIVIANO A TOLERANCIA, ASISTIDO
3. AMIODARONA 200 MG 1 DIA VO
4. OMEPRAZOL 20 1 DIA VO
5. ESPIRONOLACTONA 25 1 DIA VO
6. PROPANOLOL 10 MG CADA 12 VO
7. DIAZEPAM 10 MG NOCHE VO
8. CEFTRIAXONA 2 GR DIA EV X 3 DIAS
9. KINE R Y M POR HODOM
10. CONTROL POLI CARDIO 10 DIAS

EXÁMENES Y RESULTADOS

Ecocardiograma: estenosis valvular aortica severa, insuficiencia valvular aortica moderada, esclerosis valvular mitral, insuficiencia mitral y tricúspide leve. VI dilatado. Fevi conservada. VD normocontractil. Pericardio sin derrame.

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

RENE GOZA MEDINA
MEDICO TRATANTE
13128904-9

JEFE SERVICIO